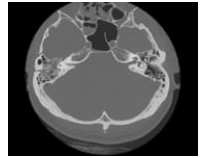


Manifestation en cas de fracture du col du fémur :
Jambe raccourcie et rotation externe

Fracture diaphyse humérale. Extension du poignet et des doigts impossibles. Nerf lésé :
Nerf radial

Jeune sportif a été frappé par une crosse à la tempe pendant un match de hockey sur glace. À quoi devez-vous faire attention dans l'état clinique ? K-Prim. CT :
Paralysie du nerf facial, otorrée, vertige (pas anosmie)



Le patient de 23 ans se présente avec une tuméfaction à l'angle de la mâchoire après un coup de poing. Perte de sensibilité de la lèvre inférieure gauche. La radiographie montre une fracture déplacée de l'angle de la mâchoire gauche. Quel nerf a été touché :
Nerf alvéolaire inférieur

Environ une semaine après une fracture de la base du crâne, un homme se plaint de rhinite aqueuse quotidienne. Que faire :
Recherche de la beta2transferrine

CaT morsure de vipère
Vaccin antitétanique intramusculaire

Traumatisme doigt IPD → Hématome sous-unguéal :
Trépanation de l'ongle

Quelle propriété d'un médicament entraîne une augmentation de la fréquence des effets indésirables des médicaments (ADR) et des taux d'effets secondaires ?
Faible biodisponibilité

Médicament pouvant induire une hyperthyroïdie/hypothyroïdie :
Amiodarone

Un patient présente depuis plusieurs semaines des symptômes typiques de l'hyperthyroïdie, dont une fibrillation auriculaire. Quel médicament pourrait être responsable de cette situation ?
Amiodarone

Médicament responsable détérioration fonction rénale :
AINS

HTA par IEC (ou sartan et diurétique ?). Douleurs au dos depuis 8 semaines traitées par AINS et mnt elle a une HTA péjorée. Quelle est la cause ?
AINS

Antihypertenseur qui ne doit pas être administré à une femme enceinte :
IEC

Antihypertenseur à éviter en cas de risque de goutte :
Diurétique thiazidique

Angioœdème au niveau de la lèvre chez un patient avec IEC, statines, diurétique thiazidique, a mangé hier salade, poulets, frites, yoghourt, Que faut-il faire :
Switcher IEC pour bloqueur récepteur Angiotensine (angioœdème bradykinique causé par les IEC et développé tardivement)

Effets indésirables potentiels après CT avec produit de contraste :
Urticaire, Œdème de Quincke (angioœdème), Bronchospasme, Choc anaphylactique

Le patient est sous ASA, statines et nouvel antibiotique. Développe des douleurs musculaires et une élévation de la CK. Quel AB est le plus susceptible de causer cela ?
Clarithromycine

Patient à qui on donne de l'halopéridol et qui par la suite présente une rigidité, une hyperthermie, une mydriase :
Effet secondaire halopéridol/syndrome neuroleptique malin

Jeune femme hospitalisée pour fracture du tibia. Reçoit du Métoclopramide (Primperan) : Ne peut plus bouger les yeux. Regard fixé vers le haut : Crise oculogyre car Métoclopramide responsable de Symptômes extrapyramidaux (comme Haldol et autre antipsychotiques typiques). Antidote :
Biperiden (Akineton) (Anticholinergique/Antimuscarinique)

Un héroïnomane est diagnostiqué schyzophrène. Le psychiatre lui prescrit donc de l'halopéridol et du diazépam. Trois jours après le début du traitement, il est admis aux urgences avec des troubles de la marche et des crampes de la langue et de la gorge. Que faut-il injecter d'urgence ?
Anticholinergique (L'halopéridol peut induire des symptômes extrapyramidaux dont des dystonies aiguës, le traitement en aigu consiste en des anticholinergiques qui diminuent l'hyperactivité cholinergique du SNC causée par les symptômes extrapyramidaux)

Homme jeune présente des saignements de nez récurrents. L'examen nasal montre une perforation nasale septale antérieure, à quoi pense-t-on en premier :
Cocaïne

Cocaïnomanie qui se présente aux urgences avec dyspnée et angine de poitrine, quel médicament est contre-indiqué :
B-bloquant

Alcoolique qui arrive à l'hôpital confus, pertes de l'équilibre, non orienté, nystagmus, quoi donner :
Thiamine

Un patient de 45 ans entre à l'hôpital la veille au soir d'une opération. Les valeurs suivantes ont été recueillies : Y-GT élevé, pouls 120, TA 180/110, transpiration, tremblements de mains. Quelle thérapie est la plus susceptible d'être indiquée ?
Benzodiazépines

Quelqu'un qui ingère un liquide inodore et présente par la suite une tachycardie avec acidose métabolique à trou anionique augmenté, suspicion :
Ethylène glycol (antigel)

Un ouvrier agricole de 45 ans remplit la remorque de son tracteur de produit phytosanitaire dans un local fermé. Il se présente avec dyspnée, TA 100/60, FC 50, salivation ++, pupilles légèrement dilatées, PeC :
Atropine (intoxication anticholinestérasiques organophosphorés insecticides)

Crises d'épilepsies tonico-cloniques généralisées depuis 6 ans suite à un accident de la voie publique. Traité par acide valproïque. Hospitalisé pour une broncho-pneumonie avec un traitement antibiotique de amoxicilline/acide clavulanique. Durant l'hospitalisation il a présenté en l'espace de 4 heures, 2 crises focales prenant le membre supérieur droit puis 1 crise focale progressant en crise généralisée tonico-clonique avec altération de la conscience. Maintenant en état de mal depuis 20 minutes avec EEG qui le montre. Que faire :
Administrer des benzodiazépines iv (midazolam ou je crois c'était du diazépam?) puis de la phénytoïne iv

Toxico et OH chronique (donc malnutrition) présente. Un gonflement des gencives, des ecchymoses récurrentes et des pétéchies au niveau des avant-bras :
Carence en vitamine C (Scorbut)



Trouble érectile. Quel médicament est une contre-indication à prescrire le Sildénafil (= Viagra) :
Dinitrate d'isosorbide (L'effet hypotenseur des dérivés nitrés est potentialisé)

Hémorragies rétinienne en flammèches chez un enfant :
Maltraitance (Syndrome du bébé secoué)

Facteurs de risque de la mort subite du nourrisson :
Dormir dans le lit des parents, Température de la chambre > 21°C

→ Facteurs protecteurs : Sur le dos dans son propre lit, dans une gigoteuse, sur un matelas ferme, sans couverture ni duvet ni oreiller ni peluches. S'il y a un tour de lit, faites en sorte qu'il soit adapté au lit du bébé ; attachez-le aux barreaux et glissez-le sous le matelas. Tétine/lolette recommandée (ouvre les VAS). Son lit dans la chambre des parents. Aérer la chambre tous les jours. Température de la pièce entre 18°C et 20°C. Pas trop habiller le bébé (si forte chaleur). L'allaitement maternel diminue le risque de mort subite du nourrisson. Pas de fumée dans l'espace de vie du bébé.

Scrotum tuméfié, homogène et indolore, gonflement asymétrique, diaphanoscopie positive :
Hydrocèle

Ado, douleur intense des testicules. Testicule remonté, rouge, tuméfié, et douloureux à la palpation. Bandelette urinaire normale :
Explorer chirurgicalement

Garçon réfugié de 8 ans, le jumeau B, né à 34 semaines avec un développement initialement normal, a appris à marcher à l'âge de 19 mois, alors que sa sœur jumelle était capable de le faire à 14 mois. A l'examen, marche sur la pointe des pieds, hyperréflexie dans toutes les extrémités et un tonus légèrement augmenté, cause :
Tétraspasticité des jambes sur naissance prématurée

Enfant de 13 ans sans poils avec des parents plutôt petits :
Retard de croissance constitutionnel

Un garçon de 15 ans consulte son médecin de famille en raison d'un surpoids et d'un retard de puberté. Hauteur 172 cm, poids 70 kg . Il se sent par ailleurs en bonne santé. Poils pubiens P4, gynécomastie légère, taille des testicules 4-5ml . Quelle est la procédure à suivre pour confirmer votre diagnostic présumé :
Caryotype

Un nouveau-né développe une jaunisse néonatale. L'oncle a une déficience connue en glucose-6- phosphate déshydrogénase. Que faut-il faire d'autre avant que la mère ne rentre chez elle avec le bébé 48 heures après la naissance ?
La bilirubine

Un enfant de 2 mois dont l'adaptation postnatale est sans problème vient pour le contrôle car il n'a pris que 500g depuis sa naissance. Il a bon appétit et boit bien. Depuis quelques jours, la mère a remarqué une légère toux pendant la journée. Quelles sont les autres étapes utiles ? K-Prim.
Test de la sueur, Rx pour évaluation du médiastin (pas test transglutaminases ni conversion au lait de soja)

Un enfant de 2 ans est présenté au pédiatre par sa mère inquiète. Elle dit qu'il se développe plus lentement que ses deux grandes sœurs. Même s'il mange très peu, il a un abdomen distendu mais souple à la palpation. Les 5 premiers mois, elle l'a allaité sans problème. Le garçon est de taille et de poids <3 percentiles, il est pâle et pleurnicheur et a un abdomen proéminent. Que faites-vous :
Ac-Transglutaminase

Fille de 3 ans avec fièvre, perte de l'envie de jouer, sialorrhée, changement de voix, quel vaccin faut-il demander :
H.influenzae B

Enfant de 14 ans, en surpoids, présent des douleurs au genou depuis plusieurs semaines. A l'examen le genou est indolore et mobile, Dg le plus probable :
Epiphysiolyse de la tête fémorale

Garçon de 4 ans qui ne veut plus courir ni manger depuis ce matin. Hier il était encore en bonne santé. VS et leucocytes dans la norme. Rotation de la hanche limitée. Petit épanchement noté au sein de l'articulation :
Coxitis Fugax/Rhume de hanche/Synovite aigue transitoire de la hanche

Fille de 12 ans présentant des papules desquamantes disséminées généralisées. 5 jours avant elle avait mal de gorge et de la toux. Diagnostic ?
Psoriasis en goutte

K-prim : Quelles sont les caractéristiques typiques de la dermatite atopique :

Rides de Dennis Morgan, Eczéma du mamelon, Kératose pilaire (et pas formation d'ampoules sur les mains et les pieds)

Patients en soins intensifs, se plaignent après quelques jours de démangeaisons, surtout interdigitales et inguinales. De nombreux soignants et autres patients sont également concernés. Quelle est la cause la plus probable :
Gale

Une mère emmène sa fille de 4 ans chez le médecin pour un œdème. La mère signale que la fille a probablement eu un léger rhume, mais celui-ci s'est déjà dissipé. Le médecin découvre une protéinurie dans la zone néphrotique. Le sang micro ou macroscopique n'est pas visible dans l'urine. La pression artérielle est dans la fourchette normale et le BSG est élevé.

Glomérulonéphrite Minimal Change Disease

Bursite genou, on fait une ponction, que cocher pour le labo :
FR, Leucocytes, culture, microscopie à polarisation

Femme de 50 ans en bonne santé jusqu'à présent. A été traitée récemment pour une sinusite. Actuellement se plaint de nodules douloureux, pupura et ulcères aux membres inférieurs. Avec une clairance de la créatinine de 35ml/min et une radiographie avec deux foyers pulmonaires ronds et assez bien définis :

Wegener

Description d'une suspicion clinique de Horton avec : > 50 ans et symptômes visuels ou céphalées nouvelles ou claudication de la mâchoire ou polymyalgia rheumatica et VS > 50, première chose à faire :

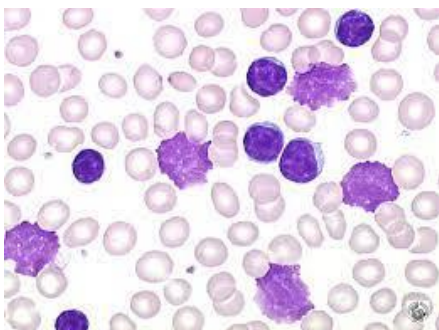
Corticothérapie immédiatement

Patient 20-40 ans, aphtes chroniques, érythème noueux, uvéite, et douleurs articulaires :
Maladie de Behçet

Patient de 22 ans, douleur de type mécanique au pli de l'aîne depuis un mois. Palpation de la hanche et du grand trochanter douloureuse. Boiterie à la marche No CRP, no fièvre, FSC N, radio bassin :



Tumeur du col



Leucémie lymphoïde chronique (Gumprecht)

Qu'est-ce qui est responsable du plus grand nombre d'années de vie potentiellement perdues pour les femmes entre 1 et 70 ans :

Carcinome du sein

Patiente qui palpe une grosseur dans son sein, ATCD familiaux de cancer du sein :

Échographie des seins et mammographie

Patiente avec carcinome du sein, quel examen immunohistochimique n'est pas recommandé :
E-cadherin 17 (contrairement à HER2, indice de prolifération, récepteurs à la progestérone, récepteur aux oestrogènes)

Patiente avec carcinome ovarien présente une ascite et une dyspnée. Que faire :
Ponction diagnostique (sauf si CVD cliniquement évident)

Quelle tumeur pulmonaire peut induire une hyponatrémie :
Carcinome bronchique à petites cellules

Un patient de 62 ans, connu pour une BPCO et un carcinome pulmonaire à petites cellules traité par chimiothérapie palliative, se présente pour un état fébrile une semaine après sa dernière cure. Il présente une dyspnée associée. Au status, on retrouve un état fébrile à 39°C, une fréquence cardiaque à 115/min et une tension artérielle à 90/70, également une fréquence respiratoire à 22/min. Le laboratoire montre des leucocytes à 1.1G/l, dont 0.15 neutrophiles, une CRP à 90 mg/l. Des hémocultures sont en cours.

Quelle est la prise en charge la plus appropriée ?

- A. Fébrifuges et contrôle ambulatoire à 24h
- B. Fébrifuges et hospitalisation pour surveillance
- C. Amoxicilline-clavulanate p.o. et contrôle ambulatoire
- D. Amoxicilline-clavulanate en i.v. et hospitalisation pour surveillance
- E. Céfépime en i.v. et hospitalisation pour surveillance

On découvre qu'un charpentier à la retraite a une tumeur dans la région ORL qui saigne légèrement à la palpation. Antécédents médicaux : Fumeur. Neurologique : parésie du regard vers le haut. Un diagnostic suspect ?
Adénocarcinome

Une patiente de 55 ans vient vous voir en tant que médecin de famille. Son père souffre de cancer du côlon à l'âge de 70 ans et elle aimerait savoir ce qu'elle peut faire pour réduire son risque de côlon cancer. Quelle est la mesure la plus efficace pour réduire son risque à long terme :
Coloscopie

Qu'est ce qui ne convient pas pour calculer un écart type ?
Stade tumoral

Un ancien fumeur invétéré de 80 ans. TURP il y a 20 ans. HTA connue. Insuffisance cardiaque depuis 3 mois. Le patient veut savoir ce que vous pensez d'un dépistage par le PSA dans sa situation. Pourquoi un dépistage n'est pas indiqué :
Son espérance de vie

Quel est le paramètre le plus fiable pour déterminer l'efficacité d'une thérapie oncologique ?
Survie

Un patient de 60 ans vous consulte en raison de difficultés progressives à uriner : le patient se plaint d'un affaiblissement de son flux urinaire. Vous apprenez que le patient souffre de plus en plus de nycturie et de pollakiurie. Quelle thérapie proposez-vous au patient ? (Hyperplasie bénigne de la prostate)
Tamsulosine/Prazosine/Alpha-antagoniste

Patient traité pour une polyarthrite et une hyperplasie bénigne de la prostate avec les médicaments mentionnés. Lequel d'entre eux est le plus susceptible d'être responsable de l'apparition d'une hypotension orthostatique :
Tamsulosine (alpha-bloquant)

Aux urgences, se trouve un patient avec un abdomen aigu. Vous soupçonnez une perforation de l'intestin. Quel type d'imagerie faites-vous ?
Rx Abdomen couché en position latérale ou Rx Thorax debout

Petit enfant aux urgences. Douleurs abdominales horribles et intermittentes (va bien au status) depuis quelques jours. Un peu de sang au TR. US montre :
Invagination



Examen de première intention lors d'une vignette décrivant une suspicion d'appendicite :
US

Patient arrive avec un abdomen aigu, quelle proposition est juste concernant les US :
L'US est la méthode de Dg de choix pour la cholécystite

Un homme de 35 ans se présente pour un contrôle radiologique. La radiographie montre une vésicule biliaire pleine de calculs. Le patient ne présente aucun symptôme. Quelle est la prochaine étape :
Ne rien faire

Femme de 50 ans après ERCP avec papillotomie pour un calcul biliaire. Au départ, bon déroulement postopératoire. Le 4e jour postopératoire, elle développe une douleur intense dans le haut de l'abdomen, quelle en est la cause ?
Pancréatite aiguë

Patient jeune avec un IMC de 42. Plusieurs tentatives de régime infructueuses depuis 2 ans, IMC jamais en dessous de 39. Prochaine étape :
Orientation vers chirurgie bariatrique

Un patient de 72 ans est traité à la prednisone en raison d'une artérite temporale diagnostiquée il y a deux mois. Ce taux pourrait être réduit de 50 mg/j à 30 mg/j. Le patient se présente maintenant avec une fatigue et une polyurie nouvellement apparue. Il a également le sentiment d'une soif accrue. Quel est le diagnostic le plus probable :
Diabète sucré décompensé (ES corticothérapie)

Diabétique traité par Metformine et Insuline a une HTA résistante. Conseil de faire du sport → PC de quelques minutes. Cause la plus probable ?
Hypoglycémie

Une patiente de 56 ans se présente à votre bureau parce qu'elle a mesuré un taux de glucose sanguin de 7,2 avec l'appareil de mesure de sa sœur qui souffre de diabète sucré. Elle s'inquiète de la possibilité qu'elle soit également atteinte de diabète et souhaiterait obtenir des éclaircissements à ce sujet. Il n'y a ni polyurie, ni fatigue veineuse, ni perte de poids. Quelles précisions apportez-vous ?
Déterminer la glycémie à jeun

Une patiente de 80 ans, connue pour une cardiopathie ischémique depuis 15 ans et hypertensive et d'un diabète sucré de type II qui existe depuis des années a subi une PTG élective sur le côté gauche il y a deux jours. Elle se plaint maintenant de douleurs abdominales aiguës, son état montre un abdomen clairement distendu. Sur l'image radiographique, elle voit de multiples anses dilatées dans l'abdomen et le laboratoire montre une hypokaliémie. Quelle pourrait être la cause de ses symptômes ? K-Prim.
L'hypokaliémie, analgésie à la morphine, Immobilité, déshydratation

Kyste hépatique hypoéchogène retour de voyage, kyste amibien? Hydatique? Alvéolaire? Échinococcose ?

Un patient de 22 ans atteint d'un ictère indolore suite à une infection de type grippal. Labo : bilirubine indirecte augmentée, directe légèrement augmentée, ALAT et PA dans la norme, bon état général. Diagnostic le plus probable :
Syndrome de Gilbert

OH chronique : aux urgences pour dyspnée, fatigue, ictère, angiome stellaire et érythème palmaire. Abdomen distendu mais souple et non douloureux. Rate palpable à 5cm sous le rebord costal. Au labo : pancytopenie. Raison de la thrombocytopénie :
Hypersplénisme

Dame âgée se présente pour des selles liquides. Elle prend régulièrement des laxatifs en raison d'une constipation chronique. A l'examen il y a des taches de sang et une saillie circulaire dans l'anus :
Prolapsus du rectum

Femme de 72 ans avec un ulcère de 5 cm sur la face interne de la cheville, également atrophie blanche, hyperpigmentée et variqueuse. Quel est le test approprié pour le diagnostic :
US duplex

Ulcère malléole interne :
Insuffisance veineuse

Ulcère malléole externe :
AOMI

Quel est le meilleur test de dépistage pour l'AOMI :
Indice cheville-bras (ABI)

Un homme d'une quarantaine d'années se présente au cabinet du médecin généraliste. Son frère est décédé il y a peu de temps d'une mort cardiaque subite. Le patient constate maintenant qu'il souffre de vertiges récurrents lors de la pratique d'un sport ou d'un effort. A l'examen clinique, vous remarquez un crescendo-decrescendo systolique au milieu du cœur. En se penchant en avant, pas de diastolique, mais une systolique amplifiée perceptible à l'auscultation. Quel est le diagnostic le plus probable :
Cardiomyopathie hypertrophique obstructive

Patient souffrant d'insuffisance cardiaque post PTA avec drug eluting balloon. Valeurs lipidiques normales. Qu'est-ce qui peut être arrêté car n'améliore pas le pronostic à long terme :
Digoxine

56 ans, serrurier, fumeur 35 UPA, obèse et de nombreux FRCV. HTA, DT2, cholestérol élevé sans traitement. Quel traitement est le plus important en termes de pronostic :
Arrêt du tabac

Cause la plus fréquente d'ACR suite à un traumatisme :
Fibrillation ventriculaire (FV)

Homme d'environ 40 ans atteint d'artériosclérose connue, avec dyspnée soudaine, visage cyanosé et mousse dans la bouche. TA 240/140mmHg, troponine légèrement élevée sans autre augmentation après 3h. Le diagnostic le plus probable :
Crise hypertensive

Patient de 40 ans souffre d'HTA malgré la mise en place d'une trithérapie. Créatinine légèrement augmentée depuis le dernier contrôle. Prochaine étape :
Échographie Doppler Duplex de l'abdomen

Patient stenté il y a 1 mois, sous DAPT (Aspirine + Clopidogrel) pour 6 mois. Doit subir une cholécystectomie dans les 3 prochains mois :
Attendre 8-12 semaines puis stop Clopidogrel et opérer sous Aspirine

Homme de 40 ans, se présente pour enrouement chronique, ATCD d'accident de voiture avec nombreuses fractures, lien entre accident et symptomatologie :
Pseudo anévrisme de l'aorte thoracique dans la région de l'isthme

Patiente de 45 ans souffrant de douleurs intenses, de rougeurs et d'un gonflement de la jambe droite. L'US de compression confirme une TVP : quelle est la meilleure thérapie pour prévenir un syndrome post-thrombotique ?
Bas de compression pendant 1 an

Patient souffrant d'EP se présente avec un O2 bas, un CO2 bas et un pH bas, pourquoi :
Trouble de distribution

Fumeur de 35 ans, depuis 2 ans d'hypertension, a remarqué il y a 5 jours que ses pupilles sont de taille inégale, du côté droit plus petites avec une paupière légèrement tombante. Il y a sept jours, il a fait une violente chute en skiant, sans perte de conscience. Une autre évaluation ?

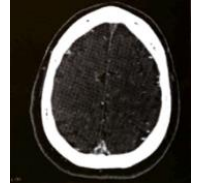
Carotide Doppler

Homme sans ATCD médicaux s'évanouit le matin en se rasant. La TA est de 157/65, le pouls de 52/min est régulier. Cause la plus probable :

Syndrome du sinus carotidien

Femme de 30 ans souffrant de graves maux de tête. Un scanner avec un produit de contraste est effectué et un "signe delta vide" est trouvé. Quel est le diagnostic le plus probable ?

Thrombose sinus veineux



Un homme est soudainement atteint d'hémiplégie et d'aphasie globale à 7 heures du matin. Sa femme a remarqué qu'il était aux toilettes à 6h15, normal. Urgence à 8h00, le scanner ne montre aucune ischémie ou saignement visible. Que faire :

Thrombolyse

Un patient séropositif de 50 ans, est amené par sa famille en raison de changements dans son caractère avec un comportement agressif et sans tact qui sont présents depuis quelques mois. Dans la clinique, il harcèle les infirmières avec des remarques obscènes. Où la lésion cérébrale est-elle le plus susceptible de se situer ?

Frontale

Patient âgé avec la triade ataxie posturale + démence + incontinence :

Hydrocéphalie à pression normale

Homme de 86 ans, instabilité à la marche, petits pas mais balancement des bras normal, pas d'instabilité posturale, MMS 25/30, pas de stase vésicale, Dg le plus probable :

Hydrocéphalie à pression normale

Après une semaine de diarrhée aqueuse : perte de force progressive aux MI, diminution sensibilité symétrique et aréflexie = Guillain-Barré :

PL

Jeune patient, problèmes de vision : Paralysie de l'adduction de l'œil gauche avec nystagmus de l'œil droit lors du regard à droite. Reste oculomotricité sp :

Ophtalmoplégie internucléaire

Un homme de 55 ans se présente dans votre cabinet avec une perte d'audition à gauche. Lors de l'examen clinique, vous trouverez un test de Weber latéralisé à gauche, Rinné à gauche négative, à droite positive. Le conduit auditif est rougi, le tympan n'est pas visible. Lequel des symptômes suivants nécessite une paracentèse immédiate :

Vertiges

Éducateur de 25 ans avec un enrouement, surtout après forçage. Besoin d'éclaircir la gorge et sensation de corps étranger. Non-fumeur. Le diagnostic le plus probable :

Nodules des cordes vocales

Tuméfaction pré-auriculaire. Liquide purulent qui sort du canal excréteur parotidien à la pression :

Sialadénite bactérienne

Patient avec nodule douloureux au niveau de la paupière inférieure, vision 10/10 :

Hordeolum (orgelet)

Un enfant louche. Après des gouttes locales d'atropine, il ne louche plus. Suspicion :

Hypermétropie non corrigée

Quel est le diagnostic le plus probable chez une femme souffrant de 3 fausses couches et d'une embolie pulmonaire momentanée sur une thrombose veineuse profonde ?

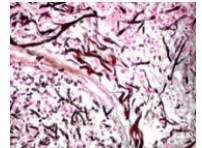
Le syndrome des antiphospholipides

Patiente en aménorrhée depuis 8 semaines va pas bien du tout. Fortes douleurs dans le quadrant inférieur droit et dyspareunie. US : liquide dans le Douglas et quelque chose aux annexes → Suspicion de GEU. Patiente hypotendue (90/60 mmHg) et tachycarde (110 bpm). Que faire :
Laparotomie (car signes de rupture ectopique potentiel et de choc)

Femme avec 4 accouchements (2 voie vaginale, 2 voie césarienne) arrive à l'hôpital avec de légères contractions à 41 1/7 semaines de grossesse. L'enfant se trouve en position transversale, conduite à tenir :
Césarienne

Une femme post-partum a une température de 37,8 C. La position de l'utérus est à 3 doigts sous le nombril, la déchirure périnéale suturée est calme. Elle a des rhagades sur la poitrine. La poitrine est tendue mais indolente. Le stix urinaire indique Lc +, protéine -, nitrite -, glucose +. Quelle est la cause de l'augmentation de la température ?
Montée de lait

Femme de 37 ans se présente aux urgences avec une douleur au flanc gauche. EF à 39, signes vitaux dans les limites de la norme. Calice rénal dilaté à l'US. Quelles mesures prendre :
A, B et C (correspond à stix urinaire, hémoculture, paracétamol et AB)



Patient de 40 ans ayant subi une transplantation rénale et présentant des symptômes de pneumonie. Quelle est la cause la plus probable ?
Aspergillose

Jeune patiente, nouveau partenaire. Douleurs abdo basses, pertes vaginales purulentes, EF, et mobilisation de l'utérus douloureuse. TG négatif et US transvaginal s.p. → PID (Gono/Chlam). Complications ?
Stérilité, Douleurs abdominales basses chroniques, Grossesse extra-utérine, Péri-hépatite

Femme revenant de Saint-Domingue avec diarrhée aqueuse et vomissements depuis 3 jours, pas de sang dans les selles, Dg le plus probable : Enterotoxigène Escherichia Coli (ETEC)

Femme enceinte présente une méningite (PL : clair, pléocytose, lympho ++), pathogène le plus probable :
Listéria

Patiente hospitalisée post-intervention chirurgicale. Contracte une Pneumonie à Légionelle. Mesure épidémiologique :
Rechercher Legionella dans l'eau courante de la chambre

Une femme enceinte attend avec impatience les vacances d'hiver qui commenceront demain. Cependant, quelques heures après avoir mangé du fromage à la crème, elle développe une fièvre et des douleurs aux membres. La fille rentre de la maternité et nous parle d'un enfant atteint de varicelle (depuis hier). Quel agent pathogène est le plus probablement responsable des symptômes de la mère ?
La grippe

Patiente de 92 ans (= à risque de complication), baisse EG, état confusionnel, EF, rhinorrhée. Auscultation pulmonaire sp. SaO2 92%. Frottis grippe positif :
Oseltamivir

Parkinsonien, fausse route fréquente : Pneumonie d'aspiration :
S. Pneumoniae

Le personnel infirmier signale que le patient, qui doit être opéré dans 2 heures et n'a donc rien mangé depuis minuit, vient de boire une tisane. Que devez-vous faire maintenant ?
Dites au patient qu'il n'est désormais plus autorisé à boire.

Patient opéré (œsophagectomie) développe une dyspnée aiguë et un stridor inspiratoire lorsqu'il a été désintubé. Cause :
Paralysie bilatérale du nerf récurrent

4h post thyroïdectomie totale présente des paresthésies péri-buccales et au niveau des mains, ainsi que des crampes aux mains. Légère dyspnée. Cause :
Hypocalcémie

Un jour après une opération abdominale, une femme de 82 ans présentait un gonflement douloureux du genou et une fièvre de 39 degrés. Son état général est réduit. Quelle est la prochaine étape pour confirmer le diagnostic présumé ?
Ponction du genou

K-prim : patiente de 50 ans atteinte d'un cancer du sein avec de multiples métastases, notamment dans le squelette axial et le cerveau. Douleurs extrêmes, de sorte qu'il n'est pas possible de la déplacer. Elle a pris jusqu'à présent de la morphine retard 10 mg 1-0-1. que faire dans le cadre d'un setting palliatif ?
Biphosphonates, augmenter la dose journalière de morphine, prescrire des gouttes d'action rapide en cas de douleur aiguë (réponse fausse: la dose maximale de morphine est de 150mg par jour)

Patient âgé qui se présente au cabinet avec sa fille qui a emménagé récemment chez lui. Elle dit que son père oublie beaucoup de choses ces derniers temps. Le père ne répond à aucune question hormis quand la fille s'adresse à lui. Le père sent l'urine et a des hématomes sur les avant-bras. Diagnostic probable :
Maltraitance

Un homme de 86 ans. Bien remis après une pneumonie. A la maladie de Parkinson, des vertiges avant même l'admission à l'hôpital avec instabilité à la marche et risque de chute. Il est cependant autosuffisant. Appartement accessible aux fauteuils roulants. L'évaluation gériatrique montre une tendance à la régression, Mini Mental 26/30. Quelle aide à la mobilité ?
Rollator

Homme de 34 ans, hospitalisé pour un épisode dépressif et en cours de traitement. Au cours du rapport du matin, l'infirmière de nuit rapporte que la patiente n'a presque pas dormi et lui fait des remarques salaces. Début d'épisode maniaque (Nb : on retrouve souvent une dépression précédant l'épisode)

Patiente de 23 ans, souffrant de troubles alimentaires depuis quatre ans. Réduction quantitative et qualitative de son comportement alimentaire ainsi que des crises de boulimie 2-3 fois par semaine, accompagnées de vomissements. Conséquence la plus importante à court terme :
Dommages dentaires

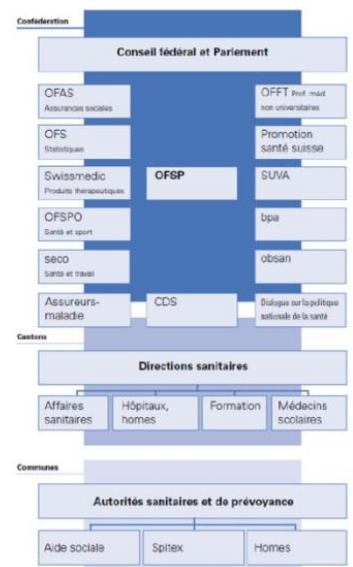
Étudiant de 22 ans se présente chez le médecin de famille et souhaite qu'on lui prescrive un somnifère. En cours de discussion il dit qu'il se sent triste et que les prochains examens lui mettent beaucoup de pression. Le patient vous fait une triste impression :
Clarifier les tendances suicidaires

Une adolescente vient à votre cabinet et veut se faire prescrire la pilule contraceptive. Elle ne veut pas que ses parents le sachent. Vous pouvez lui prescrire la pilule si elle :
Capable de discernement

Un patient de 17 ans souffrant d'appendicite doit être opéré. Le patient est légèrement irritable et déconcentré. Qu'en est-il de sa capacité à prendre une décision concernant l'opération ?
Capable de discernement

Vous êtes appelés par une voisine chez une femme de 89 ans. Le voisin a trouvé la femme souffrant de démence dans la cage d'escalier. Il devient rapidement évident que la vieille femme est morte. Selon la voisine, les enfants se disputaient l'héritage et la vente de l'appartement. Que faire ensuite :
Alerter la police pour des raisons médico-légales et autres clarifications

Constat de décès par le médecin de garde à domicile, la porte doit être forcée pour rentrer dedans. A l'intérieur, corps en état de décomposition avancé. Le médecin traitant est contacté et dit que l'habitante de l'appartement est connue pour des maladies cardio-vasculaires et a fait un infarctus il y a 6 mois.
Appeler la police



Une étude a été menée sur l'ostéoporose chez les femmes postménopausées. Dans deux groupes, 2500 femmes chacun ont été observées sur une période de 2 ans. Dans le groupe thérapeutique, 200 fractures du corps vertébral ont été observées, dans le groupe standard (tout autre terme), 250 fractures du corps vertébral ont été observées. Les fractures du corps vertébral se produisent continuellement. Combien de patients doivent être traités pendant 10 ans pour prévenir une fracture du corps vertébral ?

NNT=10

Le test a une sensibilité de 11% et une spécificité de 95%. Comment se comportent la sensibilité et la spécificité par rapport à un 2ème test.

La sensibilité augmente, la spécificité diminue

Les 5 hôpitaux universitaires suisses coordonnent l'admission des cas dans la cohorte nationale des patients atteints de maladies inflammatoires chroniques de l'intestin. Une analyse a montré une forte prévalence de patients ayant des antécédents de complications graves de la maladie de Crohn. Quel parti pris a conduit à cela ?

Biais de sélection

TCC, un garçon est exposé à plusieurs examens radiologiques (énumérés en détail) et est ainsi exposé à une dose totale de 30 mSv. Les parents veulent maintenant savoir comment cette exposition aux radiations affectent leur enfant. Que dites-vous aux parents ?

Le niveau de rayonnement appliqué est inoffensif, donc aucune précaution à prendre. (< 100 mSv)

Par une chaude journée d'été, une mère amène son fils parce qu'il souffre d'une irritation des voies respiratoires.

Quelle en est la raison ?

Ozone

Rougeole :

Déclaration obligatoire en cas de suspicion (avant le résultat des sérologies) par le médecin dans les 24h